

LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR

A. Roces Fernández, G. Alonso Claro, R. Marcos Mesa.

PATOLOGÍA DE LA CINTURA ESCAPULAR

FRACTURAS DE ESCÁPULA

Poco frecuentes.

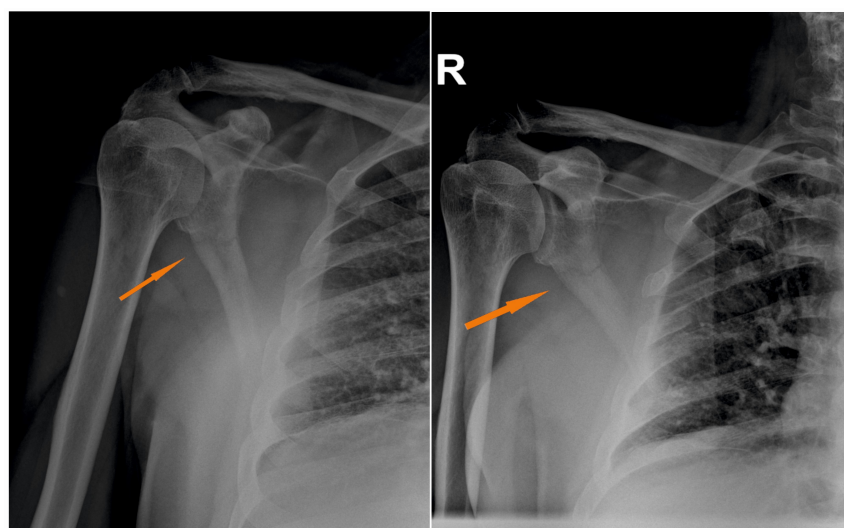
Mecanismo de lesión: Sospechar en traumatismos de alta energía, suelen asociarse a otras fracturas (costales, clavícula...).

Exploración física: dolor, inflamación y limitación funcional del hombro.

Pruebas complementarias: Radiografía anteroposterior y lateral de escápula (en Y). Suele precisar un TAC para una mejor valoración.

Tratamiento: La mayoría requieren un tratamiento ortopédico mediante inmovilización con cabestrillo.

Cirugía sólo en casos de afectación de la glena, cuando el fragmento sea mayor de 10mm y más de un 25% de la superficie articular afectada.



Fractura omóplato derecho



FRACTURAS DE CLAVÍCULA

Mecanismo de lesión: caída sobre el hombro o sobre la mano, mecanismo de compresión.

Tercio interno

Muy raras.

Exploración física: dolor y tumefacción tercio medial de la clavícula.

Pruebas complementarias: radiografía anteroposterior de hombro y proyección de “serendipia”, para ver el desplazamiento anteroposterior.

Tratamiento: conservador mediante cabestrillo.

Tercio medio

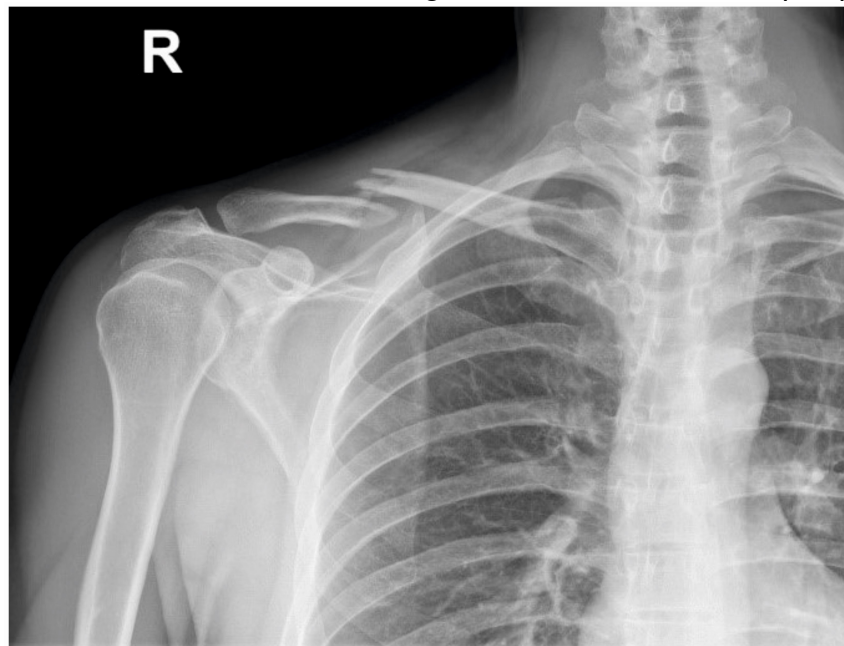
Las más frecuentes (80-85%).

El fragmento medial se desplaza hacia arriba y atrás y el lateral hacia abajo y adelante.

Exploración física: deformidad tercio medio clavícula acompañado de limitación funcional del hombro.

Pruebas complementarias: radiografía de hombro anteroposterior suficiente.

Tratamiento: la mayoría conservador mediante inmovilización con vendaje en 8. Explicar al paciente que le puede quedar un bulto, que se trata de una deformidad estética, sin repercusión funcional. Cirugía si existe un acortamiento mayor de 2cm, fracturas abiertas, fracturas que asocien lesiones vasculonerviosas o ante un desgarro cutáneo inminente por protrusión ósea.



Fractura tercio medio de clavícula derecha. Tratamiento conservador mediante vendaje en 8.

Tercio externo

El desplazamiento dependerá del estado de los ligamentos coracoclaviculares.

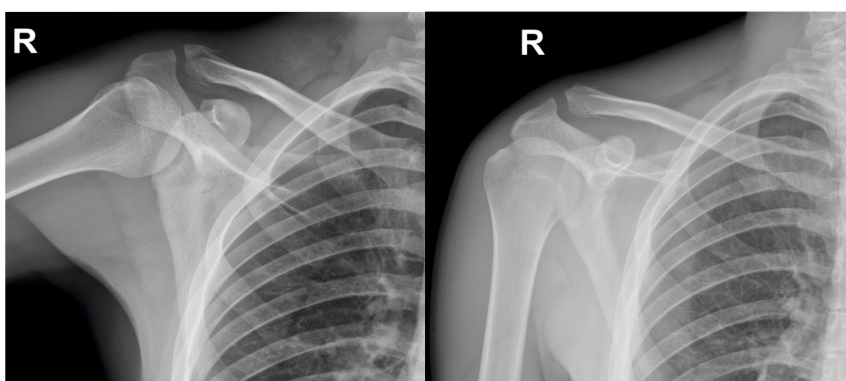
Exploración física: dolor, tumefacción y deformidad en tercio externo de clavícula. La deformidad desaparece si presionamos hacia abajo (signo de la tecla). Hacer diagnóstico diferencial con luxación acromio-clavicular.

Pruebas complementarias: Radiografía de hombro anteroposterior.

Tratamiento: depende del grado de desplazamiento, fracturas con mínimo desplazamiento intra o extra articulares tratamiento conservador mediante cabestrillo 3-6 semanas. Si existe un desplazamiento considerable avisar al traumatólogo para valorar el tratamiento quirúrgico.



Fractura luxación clavícula izquierda tercio distal



Fractura luxación clavícula derecha tercio distal

LUXACIÓN ACROMIO-CLAVICULAR

Mecanismo lesional: fuerza directa hacia abajo del acromion o por caída sobre la mano.

Exploración física: dolor, deformidad y limitación funcional tercio externo de la clavícula. La deformidad se corrige al presionar hacia abajo el tercio distal de la clavícula (signo de la tecla)

Pruebas complementarias: Radiografía de hombro anteroposterior, con el paciente en bipedestación o sentado, no en decúbito. En ocasiones puede ser necesaria una proyección en sobrecarga, con un peso de 5kg.

Tratamiento:

- **Grado I** (esguince): hielo y cabestrillo 7-10 días.
- **Grado II:** rotura de los ligamentos acromioclaviculares, existe contacto entre ambos extremos: hielo y cabestrillo 7-14 días.
- **Grado III** (rotura ligamentos coracoclaviculares, no existe contacto entre los extremos): controvertido, en general se opta por tratamiento conservador, valorará el traumatólogo.



Luxación acromioclavicular grado III. Tratamiento en función de la edad y actividad del paciente.

- **Grado IV** (Luxación posterior).
- **Grado V** (luxación superior), equivale al tipo III, pero con mayor desplazamiento).
- **Grado VI** (luxación anteroinferior): quirúrgico.

LUXACIÓN ESTERNO-CLAVICULAR

Muy raro.

Mecanismo de lesión: directo (luxación posterior) o indirecto (más frecuente) al empujar el hombro hacia atrás (luxación anterior) o hacia adelante (luxación posterior).

Exploración física: dolor y tumefacción a nivel de la articulación. En luxaciones posteriores depresión palpable y más dolor. Descartar compresión de estructuras vitales del mediastino (cogestión venosa del cuello, dificultad para tragar o respirar...)

Pruebas complementarias: radiografía hombro anteroposterior, proyección de Hobbs y serendipia.

Tratamiento: si esguince leve o subluxación tratamiento conservador mediante cabestrillo. En caso de luxación posterior: reducción en quirófano y vendaje en 8. La luxación anterior puede intentar reducirse en urgencias e inmovilización con vendaje en 8.

BIBLIOGRAFÍA

- Mc Rae. Ortopedia y fracturas de bolsillo. (Temas 19, 20 y 21).
- Campbell. Cirugía ortopédica. Tomo 6. Fracturas y luxaciones. (Capítulo 54).
- Rockwood & green's. Fracturas en el adulto. (Sección II, temas 21 – 30)